Clasificación BI-RADS de mastografía

Fuente: GPC de cáncer de mama en el primer nivel (cuadros 2 y 3), basada en ACR BI-RADS 5.ª ed. (2013). Los hallazgos de la columna “Qué describe” para las categorías 4 y 5 y las notas finales son de texto clínico estándar (ACR), no de la GPC.

Cat.	Nombre	Qué describe	Riesgo de malignidad	Conducta y nivel de atención
0	**Incompleto**	Hace falta más evaluación de imagen o mastografías previas para comparar. Se usa casi siempre en el tamizaje.	No aplica	Estudios adicionales: **ultrasonido**, mastografías previas, **compresión puntual**, magnificación o proyecciones especiales. **No se usa** si lo que se necesita es resonancia magnética.
1	**Negativo**	Mamas simétricas, sin nódulos, sin distorsión de la arquitectura, sin calcificaciones sospechosas. Se reserva para cuando **no se describe ningún hallazgo**.	**0 %**	Tamizaje de rutina según el grupo de edad y los factores de riesgo.
2	**Negativo con hallazgos benignos**	Igual que la 1, pero el radiólogo **elige describir** un hallazgo benigno: fibroadenomas calcificados, calcificaciones de la piel, cuerpos extraños metálicos, quistes, lipomas, galactoceles, hamartomas de densidad mixta, ganglios intramamarios, calcificación vascular, implantes o distorsión por cirugía previa.	**0 %**	Tamizaje de rutina. La 1 y la 2 indican **ausencia de evidencia de malignidad**.
3	**Probablemente benigno**	Hallazgo con probabilidad de malignidad **menor al 2 %**, pero mayor que la de un hallazgo característicamente benigno. No se espera que cambie durante el seguimiento.	**0 a 2 %**	**Segundo nivel.** Mastografía **unilateral a los 6 meses** (solo la mama afectada). Si está estable, **bilateral a los 12 meses**, y otra bilateral a los 12 meses más si sigue en 3. Tras **2 a 3 años de estabilidad** se recategoriza a **2**. En primer nivel: vigilancia **cada 6 meses** con contrarreferencia.
4	**Sospechoso**	Hallazgos **sin el aspecto clásico de malignidad**, pero suficientemente sospechosos para recomendar **biopsia**. Casi todos los procedimientos de intervención mamaria salen de esta categoría.	**Más del 2 % y menos del 95 %**	**Segundo nivel, clínica de mama**, para **biopsia**. En 4c se valoran estudios complementarios.
4a	Baja sospecha	Nódulo con rasgos poco sospechosos.	Más del 2 % y menos del 10 %	Biopsia.
4b	Sospecha moderada	Rasgos intermedios entre benigno y maligno.	Más del 10 % y menos del 50 %	Biopsia.

Cat.	Nombre	Qué describe	Riesgo de malignidad	Conducta y nivel de atención
4c	Alta sospecha	Rasgos muy sospechosos, sin llegar a ser clásicos de cáncer.	Más del 50 % y menos del 95 %	Biopsia y estudios complementarios.
5	**Altamente sugestivo de malignidad**	Probabilidad muy alta de cáncer. Antes implicaba cirugía en un solo tiempo sin biopsia; hoy casi siempre se confirma con **tejido percutáneo** (biopsia guiada), lo que permite planear ganglio centinela o quimioterapia neoadyuvante.	**95 % o más**	**Tercer nivel o clínica de mama**, atención inmediata y estudio histopatológico.
6	**Malignidad comprobada por biopsia**	Se usa **después de una biopsia positiva** y antes de la extirpación completa, cuando no hay otras anomalías distintas del cáncer conocido.	No aplica	**Tercer nivel**, manejo por especialista en mama. Escisión quirúrgica cuando lo permita.

Reglas para recordar

- **Una sola categoría final por estudio**, y la conducta sigue la recomendación de esa categoría.
- **El corte entre vigilar y biopsiar es el 2 %**: la 3 se vigila y de la 4 en adelante se biopsia.
- **De la 3 a la 6 se refiere.** Todo caso sospechoso, clínico o por imagen, va al especialista en mama.
- La **0 no es un resultado final**: pide más estudios.
- La **6** solo se usa con **biopsia positiva previa**.
- Si una lesión en seguimiento como 3 **crece o cambia**, se reclasifica a **4** y se biopsia.